SANTÉ

# Cholestérol : ce que le sport et l'assiette peuvent vraiment changer

*Ton médecin t'a parlé de cholestérol ? Bon et mauvais cholestérol, triglycérides : on démêle les notions, et on regarde ce que l'activité physique et l'alimentation peuvent réellement faire, chiffres à l'appui.*




NUTRITION

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

Cet article donne des informations générales. Si tu as un cholestérol élevé ou un traitement, c'est ton médecin qui fixe tes objectifs : l'activité physique vient en complément, jamais à la place de son avis.

01

## Le cholestérol, ce n'est pas l'ennemi

Le cholestérol est une graisse indispensable à la vie. Il entre dans la composition des membranes de nos cellules, sert à fabriquer certaines hormones et la vitamine D. Notre foie en produit la majeure partie, et l'alimentation en apporte une autre partie.

Comme il ne se dissout pas dans le sang, il est transporté par des particules appelées lipoprotéines. C'est là qu'interviennent les fameux bon et mauvais cholestérol.

- Le LDL-cholestérol, souvent appelé mauvais cholestérol : quand il est en excès, il peut se déposer dans la paroi des artères et favoriser l'athérosclérose, c'est-à-dire leur encrassement.
- Le HDL-cholestérol, appelé bon cholestérol : il aide à ramener l'excès de cholestérol vers le foie.
- Les triglycérides : une autre forme de graisses dans le sang, souvent augmentée par l'excès de sucres, d'alcool et le surpoids.

02

## Pourquoi c'est important

Un LDL-cholestérol durablement élevé est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Les recommandations européennes de cardiologie de 2019 sur la prise en charge des dyslipidémies rappellent que le mode de vie, alimentation, activité physique, arrêt du tabac et poids, est la base de la prise en charge, associée si besoin aux médicaments selon le niveau de risque de chaque personne.

> **Le mode de vie est la base de la prise en charge du cholestérol, avec ou sans traitement.**

03

## Ce que fait l'activité physique

Une méta-analyse publiée en 2007 dans les Archives of Internal Medicine a rassemblé 25 essais randomisés sur l'effet de l'entraînement d'endurance sur le bon cholestérol. Ses résultats sont intéressants et nuancés :

- L'entraînement augmentait le HDL-cholestérol de façon significative mais modeste, d'environ 2,5 milligrammes par décilitre en moyenne.
- La durée des séances comptait le plus : chaque tranche de 10 minutes supplémentaires par séance était associée à un gain supplémentaire.
- Un volume minimal semblait nécessaire, estimé à environ 120 minutes d'exercice par semaine.

L'effet de l'activité physique sur le LDL-cholestérol est en général plus modeste. En revanche, elle fait souvent baisser les triglycérides, améliore la tension artérielle, la sensibilité à l'insuline et aide à réduire la graisse abdominale. Au final, c'est le risque cardiovasculaire global qui diminue, et c'est ce qui compte.

04

## Le bon programme

- De l'endurance régulière : au moins 150 minutes par semaine d'intensité modérée, selon l'OMS. Marche rapide, vélo, natation, course douce. Des séances un peu plus longues, autour de 40 minutes, sont intéressantes d'après les données sur le HDL.
- Du renforcement musculaire deux fois par semaine, qui complète les effets sur le métabolisme.
- Moins de temps assis : se lever et bouger régulièrement dans la journée.

05

## Ce que fait l'assiette

L'alimentation a souvent un effet plus important que le sport sur le LDL-cholestérol. Les recommandations françaises et européennes convergent vers quelques principes :



Les bonnes huiles et les fibres

- Limiter les graisses saturées : charcuteries, viandes grasses, beurre et crème en excès, fromages en grande quantité, produits industriels comme les viennoiseries et biscuits.
- Privilégier les bonnes graisses : huiles de colza, de noix, d'olive, une petite poignée de fruits à coque par jour, du poisson gras une fois par semaine.
- Augmenter les fibres, en particulier les fibres solubles : légumes secs, flocons d'avoine, fruits, légumes. Elles aident à limiter l'absorption du cholestérol.
- Limiter les sucres et l'alcool, qui augmentent les triglycérides.
- Manger au moins cinq fruits et légumes par jour.

> **Moins de graisses saturées, plus de fibres et de bonnes huiles : l'assiette pèse lourd sur le cholestérol.**

06

## La recette du mois : porridge anti-cholestérol

Pour une personne : 40 g de flocons d'avoine, 20 cl de lait ou de boisson végétale, une pomme râpée, une cuillère à soupe de noix concassées, une pincée de cannelle. Fais chauffer doucement les flocons dans le lait 3 à 4 minutes en remuant, ajoute la pomme, la cannelle et les noix. Les flocons d'avoine contiennent des bêta-glucanes, des fibres solubles intéressantes pour le cholestérol, et les noix apportent de bonnes graisses.

07

## Et si on a un traitement ?

Les médicaments contre le cholestérol, comme les statines, sont très efficaces pour réduire le risque cardiovasculaire chez les personnes à risque. Ne les arrête jamais sans l'avis de ton médecin, même si tu fais beaucoup de sport. Et si tu ressens des douleurs musculaires inhabituelles sous traitement, signale-le-lui.

## À RETENIR

- Le LDL-cholestérol en excès favorise l'encrassement des artères, le HDL aide à l'évacuer.
- L'endurance régulière augmente modestement le HDL et diminue souvent les triglycérides.
- Un volume d'au moins 120 à 150 minutes par semaine semble nécessaire.
- L'alimentation a un effet souvent plus marqué sur le LDL : moins de graisses saturées, plus de fibres.
- Ne jamais arrêter un traitement sans l'avis de son médecin.

### SOURCES


- Kodama S. et al., Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a meta-analysis, Archives of Internal Medicine (2007) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17533202/
- Mach F. et al., 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, European Heart Journal (2020) : https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455
- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886
- Programme national nutrition santé, Manger Bouger, recommandations pour les adultes : https://www.mangerbouger.fr/